SGLT2 억제제 신규 처방 주의사항

포시가(다파글리플로진) · 자디앙(엠파글리플로진) · 슈글렛(이프라글리플로진). 혈당과 함께 심부전·신장도 보호하는 약물이지만 안전 복용을 위해 아래 사항을 꼭 확인해 주세요.

한눈에 보는 안전 복용 수칙

매일 수분 섭취	수술·시술 전 중단	콩팥 기능	생식기 진균 감염 위험
1.5~2	**3**	**eGFR ≥ 30**	**3~5**
L / 일 (탈수 예방) · 심부전 등으로 물 제한을 받은 분은 의사가 정한 양	일 전 (수술 전 3일 중단 규칙)	사구체여과율 mL/min · 이 이상에서 혈당 효과 · 포시가는 25까지 시작	배 ↑ (위생 관리 필수)

콩팥 기능 참고 — 콩팥·심장 보호 목적이면 더 낮은 수치(KDIGO 2024: 20 이상)에서도 의사가 시작할 수 있습니다.

혈당 효과와 장기 보호는 다릅니다 eGFR 45 미만에서는 혈당을 낮추는 효과가 줄어도 심장·콩팥 보호 목적은 남을 수 있습니다. 2형 당뇨병과 만성콩팥병에서는 성분별 연구와 알부민뇨 등을 함께 보고 결정하므로 수치만 보고 임의로 끊지 않습니다. 아산 28회 연수강좌 — 2026 당뇨병 update(민세희)

SGLT2 억제제는 어떻게 작용하나요?



SGLT2(콩팥에서 당을 다시 흡수하는 단백질)를 차단해 **혈당을 소변으로 직접 배출**합니다. 저혈당 위험이 낮고, 심혈관·신장 동반 환자에게 우선 권고됩니다.

기대 효과	정도
소변으로 당 배출	하루 **50~80g** · 200~320 kcal
당화혈색소(HbA1c)	약 **0.6~0.9% ↓**
체중 · 수축기혈압	체중 **2~3kg ↓** · 수축기혈압 **3~5 mmHg ↓**
심부전 · 신장 보호	당뇨 없어도 **심부전 입원 ↓ 30%** · 신장기능 악화 ↓ 40%

복용 중 일상 수칙

권장 행동	피해야 할 행동
매일 물 1.5~2L(심부전 등으로 물 제한을 받은 분은 의사가 정한 양) — 탈수·저혈압 예방의 핵심	**임의로 중단·증량 금지** — '아픈 날 규칙' 해당 시만 예외
회음부 청결 유지 — 배뇨 후 마른 수건, 통기성 속옷	**극단적 저탄수화물·키토 다이어트 금지** — 정상혈당 케톤산증 위험 ↑
정해진 시간에 매일 1회 복용 — 식사와 무관, 아침 권장	**장시간 금식·과음 금지** — 케톤 생성 자극, 탈수 가중
인슐린·메트포민은 그대로 유지 — 임의로 함께 줄이지 않기	**더운 날·운동 후 수분 부족 방치 금지** — 어지럼증·실신 위험
정기 혈액검사(3~6개월) — 신기능·전해질·당화혈색소 확인	**회음부 통증·홍반·가려움 무시 금지** — 즉시 진료 필요
약 이름·용량을 가족·다른 의료진과 공유 — 응급 시 즉시 안내	**자가 판단으로 이뇨제·소염진통제(NSAIDs) 추가 복용 금지** — 신기능 악화 위험

체중·기운이 계속 떨어지면 심부전으로 고리이뇨제를 함께 쓰는 분은 탈수·저혈압과 이뇨제 용량을 먼저 점검할 수 있습니다. 격일 복용 등으로 스스로 바꾸지 말고 체중·혈압·식사량 변화를 알려 주세요. 아산 28회 연수강좌 — 심부전 진단의 핵심 포인트와 최신 치료 가이드(이상언)

고령·저체중인 분 식사량·활동량 감소와 영양 상태를 함께 평가합니다. 노쇠하다는 이유만으로 모두 중단하는 것은 아니며 심장·콩팥 보호 목적과 생활 기능을 함께 살핍니다. 아산 28회 연수강좌 — 왜 이 환자는 계속 안 좋아질까? 개원의가 시작하는 노인 통합돌봄(백지연)

피네레논도 함께 쓴다면 칼륨과 콩팥 기능, 소변 알부민을 함께 추적합니다. 야간뇨가 두려워 물을 크게 줄이면 탈수 위험이 있으므로 수분 섭취량은 처방받은 범위에서 상의합니다. 아산 28회 연수강좌 — eGFR을 고려한 만성콩팥병의 실제적 관리(장재원)

즉시 약 중단 + 응급실 방문이 필요한 경우

아픈 날 규칙 · 일시 중단 후 의료진 연락

1. **발열·구토·설사로 식사 못 할 때** — 즉시 중단, 회복 후 재개
2. **수술·전신마취·수면내시경 3일 전** — 수술 전 3일 중단 규칙, 시술 후 재개
3. **24시간 이상 단식·급성 입원 시** — 입원 의료진에 복용 알림

즉시 119 또는 응급실

1. **정상혈당 케톤산증** — 오심·구토·복통·과호흡·과일향 입냄새 (혈당 정상이어도!)
2. **푸르니에 괴저** — 회음부·생식기 심한 통증·붓기·홍반 + 발열 (생명 응급)
3. **심한 탈수·기립성 저혈압** — 실신·8시간 이상 소변 거의 없음

함께 보기 — 설명 슬라이드 「당뇨, 오늘부터 함께 관리합니다」 edu.gwanggyobarun.com/decks/endocrine/diabetes-first-visit/

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호 · ☏ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 2025 ADA Standards of Care · 2023 KDA 당뇨병 진료지침 · KDIGO 2024 CKD Guideline · FDA Drug Safety Communication (Fournier's Gangrene, 2018)

본 자료는 일반 안내이며 개인의 상태에 따라 처방의 판단이 우선합니다.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/medication/sglt2-precautions/